

Infecções do Trato Genital Feminino e Úlceras Genitais

Conteúdo Vaginal Fisiológico

Antes de falar sobre o que é patológico, precisamos entender o que é normal. Toda mulher produz conteúdo vaginal fisiológico, e isso não é doença. Esse corrimento normal tem características bem definidas: ele é **fluido, homogêneo**, de coloração **branca ou discretamente amarelada**, em **pequena quantidade**, e o mais importante — **não arde, não coça e não tem odor desagradável**. Essa é a orientação-chave que você pode repassar para suas pacientes: se o corrimento não arde, não coça e não cheira mal, ele é fisiológico.

Se coletarmos uma lâmina desse conteúdo e levarmos ao microscópio, vamos observar células epiteliais com núcleos bem definidos, contornos celulares nítidos, sem microrganismos patogênicos e sem excesso de lactobacilos. O **pH vaginal normal fica entre 4 e 5**, mantido pela ação dos lactobacilos que produzem ácido lático. Tudo o que fugir dessas características deve nos fazer pensar em alguma patologia — e é exatamente isso que vamos destrinchar agora.

Vaginose Bacteriana

Começamos pela **causa mais comum de corrimento na mulher adulta**: a vaginose bacteriana. Primeiro ponto fundamental — vaginose bacteriana **não é uma IST**. Ela representa um **desbalanço da flora vaginal**, com diminuição dos lactobacilos protetores e proliferação de bactérias anaeróbias, especialmente a **Gardnerella vaginalis**, além de Mobiluncus, Atopobium e outras. Esses anaeróbios se aproveitam da mudança de pH para se multiplicar.

Apesar de não ser uma IST, vale lembrar que a presença de vaginose bacteriana é **fator de risco para aquisição de ISTs**, inclusive aumenta a chance de persistência da infecção pelo **HPV**. Na gestação, a vaginose sempre deve ser tratada pelo risco aumentado de **parto prematuro** — isso é cobrado em prova com frequência.

Quanto ao quadro clínico, a maioria das pacientes é **assintomática** — muitas vezes o diagnóstico será um achado incidental de citologia. Quando sintomática, a paciente apresenta um **corrimento branco-acinzentado, homogêneo**, e a característica mais marcante: **odor de peixe**.

O diagnóstico é firmado pelos **critérios de Amsel**, que são quatro pilares:

Primeiro: corrimento vaginal branco-acinzentado, homogêneo — avaliado ao exame físico. Segundo: **pH maior que 4,5** — lembre-se de que o pH normal é ácido, então na vaginose temos uma alcalinização. Terceiro: **teste das aminas positivo (teste do KOH ou whiff test)** — ao pingar hidróxido de potássio na lâmina, as substâncias voláteis produzidas pelos anaeróbios liberam aquele odor intenso de peixe. Quarto: presença de **clue cells** (células-alvo ou células-guia) na microscopia — são células epiteliais recobertas por bactérias nos seus contornos, com aspecto granuloso e bordas mal definidas.

Tratamento: trata-se apenas das pacientes **sintomáticas**, as **gestantes** (mesmo assintomáticas, pelo risco de prematuridade) e as pacientes que vão realizar **procedimentos uterinos ou vaginais** (como inserção de DIU). A primeira opção é o **metronidazol 500 mg, via oral, de 12 em 12 horas, por 7 dias**. Como os comprimidos disponíveis são de 250 mg, são dois comprimidos a cada tomada. A alternativa é o **metronidazol gel vaginal**, um aplicador por 5 a 7 noites. Para **gestantes**, sempre via oral — não há estudos suficientes comprovando eficácia da via vaginal nessa população. Como segunda opção, temos a **clindamicina 300 mg, via oral, de 12 em 12 horas, por 7 dias**.

Para os casos de **recorrência** (mais de quatro episódios por ano), as opções incluem metronidazol 500 mg de 12/12h por 14 dias, seguido de óvulos de **ácido bórico**

vaginal por 21 dias, ou metronidazol vaginal duas vezes por semana durante 4 a 6 meses.

Não é necessário tratar parceiros sexuais na vaginose bacteriana, justamente por não ser IST.

Candidíase Vulvovaginal

Passamos agora para a **segunda causa mais comum de corrimento**: a candidíase. O agente etiológico pertence ao grupo **Candida sp.**, sendo a **Candida albicans** a mais prevalente, embora existam outras espécies como a *Candida glabrata*. A cândida é um **comensal** da flora vaginal normal — ela já está lá, mas quando ocorre um crescimento excessivo, surge a doença sintomática. Portanto, assim como a vaginose, a **candidíase também não é uma IST**.

O quadro clínico é bastante reconhecível: **corrimento branco, em grumos, aderido às paredes vaginais**, classicamente descrito como aspecto de "nata de leite" ou "coalhada". A paciente apresenta **prurido intenso, ardência, disúria e dispareunia** — são sintomas irritativos/inflamatórios bem exuberantes.

O diagnóstico se dá pela anamnese, exame físico e, quando disponível, pela microscopia. O **pH é ácido, menor que 4,5** (ao contrário da vaginose, que é alcalino). O **teste das aminas é negativo**. Na microscopia, podemos visualizar **esporos e pseudo-hifas** — aqueles filamentos alongados, bem característicos do fungo.

Tratamento: a primeira opção é **via vaginal — miconazol creme vaginal** (um aplicador por 7 noites) ou **nistatina** (um aplicador por 14 noites). A nistatina tem a desvantagem da posologia mais longa, o que reduz a adesão. A segunda opção é via oral: **fluconazol 150 mg, dose única**, ou itraconazol 100 mg, dois comprimidos, duas vezes ao dia por um dia. Para **gestantes**, o tratamento é **sempre via vaginal** — fluconazol e itraconazol não são seguros na gestação.

Para **candidíase de repetição** (três ou mais episódios por ano), faz-se uma **dose de ataque** com fluconazol 150 mg nos dias 1, 4 e 7, seguida de **dose de manutenção**

com fluconazol 150 mg uma vez por semana durante 6 meses. Além disso, orientações comportamentais são fundamentais: evitar roupas apertadas, preferir calcinha de algodão, dormir sem calcinha alguns dias da semana e não permanecer com biquíni molhado.

Tricomoníase

Agora sim vamos falar de uma **IST de verdade**: a tricomoníase. Ela é causada pelo protozoário flagelado **Trichomonas vaginalis**, que pode ser identificado na microscopia pela presença do seu flagelo — é bastante característico.

Assim como nas outras vulvovaginites, a maioria das pacientes é **assintomática**. Quando há sintomas, o corrimento é **amarelo-esverdeado, fluido, abundante, bolhoso e com mau odor**. A paciente também pode apresentar ardência, prurido, disúria e dispareunia. Um achado clássico ao exame especular é o **colo em framboesa** — o colo uterino com múltiplos pontos avermelhados que, após aplicação de **lugol (teste de Schiller)**, adquire o aspecto chamado de **colpite em aspecto tigróide**.

O **pH é alcalino (maior que 4,5)**, o teste das aminas pode ser positivo ou negativo, e na microscopia identificamos o **protozoário flagelado**. O tratamento é com **metronidazol 500 mg, via oral, de 12 em 12 horas, por 7 dias** — mesma posologia da vaginose, porém aqui **obrigatoriamente via oral**, pois a via vaginal não alcança concentração suficiente para erradicar o protozoário.

Três diferenças cruciais em relação à vaginose e à candidíase: por ser uma IST, é **obrigatório tratar as parcerias sexuais**; devem-se tratar **inclusive as pacientes assintomáticas** (por exemplo, achado no Papanicolau); e a via vaginal não é aceita.

Vaginose Citolítica

Aqui está uma entidade que vem caindo cada vez mais em provas justamente por ser uma **armadilha diagnóstica**: a vaginose citolítica. Ela consiste na **proliferação**

excessiva de lactobacilos, que causam uma diminuição acentuada do pH vaginal e promovem citólise (destruição) das células epiteliais.

O quadro clínico **mimetiza perfeitamente a candidíase**: corrimento branco, prurido, ardência, queimação e dispareunia. É aquela paciente clássica que "tratou candidíase quatro, cinco vezes e não melhora". O **pH é ácido** (como na candidíase), mas a chave do diagnóstico está na microscopia: observa-se **excesso de lactobacilos, células desnudas (restos celulares por citólise) e ausência de hifas ou pseudo-hifas**.

Gravem este raciocínio: parece candidíase, mas não é. Se tratou de candidíase e não melhorou, investigue vaginose citolítica.

O tratamento é completamente diferente e elegante na sua lógica: como o problema é excesso de lactobacilos e pH muito ácido, a conduta é **alcalinizar o meio vaginal com bicarbonato de sódio**, seja por óvulos vaginais ou banho de assento.

Vaginite Inflamatória Descamativa

Esta é uma causa de corrimento que acomete mulheres na **perimenopausa e pós-menopausa**, provavelmente secundária à queda do estrogênio, que favorece um crescimento bacteriano anormal. O corrimento é **abundante, purulento**, com ardência e dispareunia associadas ao ressecamento vaginal típico do hipoestrogenismo. O pH é **alcalino**, e a microscopia mostra **aumento de polimorfonucleares** e células parabasais. O diagnóstico é de **exclusão** — precisa-se afastar vaginose, tricomoníase e outras causas de corrimento purulento. O tratamento é feito com **clindamicina associada a corticóide por via vaginal**.

Vaginite Atrófica

Outra causa de corrimento no pós-menopausa, a vaginite atrófica é causada diretamente pelo **hipoestrogenismo**. O quadro clínico lembra a vaginose bacteriana: corrimento branco-acinzentado com mau odor, porém em pequena quantidade e

associado a **ressecamento e atrofia vaginal**. É aquela paciente que tratou vaginose e não melhorou, mas tem queixa de secura vaginal — ao prescrever **estrogênio tópico**, os sintomas cedem. O tratamento é justamente com **estrogênio tópico vaginal** ou, em alguns serviços, **laser vaginal**.

Bartolinite

Mudando de assunto, vamos falar das **glândulas de Bartholin**. São glândulas localizadas **bilateralmente no intróito vaginal**, responsáveis pela lubrificação vulvovaginal. Quando o ducto dessa glândula obstrui, forma-se um **cisto**; se esse cisto infecta, temos a **bartolinite**, que pode evoluir para um **abscesso**. A sequência é: cisto, infecção, bartolinite, abscesso. A infecção é **polimicrobiana**, podendo envolver Chlamydia, gonococo, E. coli e outras bactérias.

O **cisto** isoladamente costuma ser assintomático — a paciente palpa uma "bolinha" e não sente nada. Já a bartolinite ou o abscesso cursam com **dor intensa, edema e eritema vulvar**, com uma massa que abaúla o pequeno lábio.

Conduta: cisto assintomático — conduta expectante. Cisto sintomático pequeno (menor que 3 cm) — **compressas mornas**. Cisto sintomático maior que 3 cm, bartolinite ou abscesso — **incisão e drenagem**, associada a antibiótico (doxiciclina, bactrim ou metronidazol por 14 dias). No entanto, só a drenagem tende a recidivar, então o procedimento ideal é a **marsupialização**: faz-se uma incisão em cruz sobre a glândula e evertem-se as bordas com pontos, deixando a cavidade aberta para drenagem contínua e impedindo que o cisto se reforme. Se houver recidiva mesmo após marsupialização, aí sim indica-se a **bartolinectomia** (retirada completa da glândula com cápsula), porém essa cirurgia prejudica a lubrificação vaginal e pode causar dispareunia. Portanto, a sequência é: marsupialização primeiro, bartolinectomia só em caso de falha.

Cervicite e Uretrite

Cervicite e uretrite são, na verdade, **duas apresentações da mesma doença**: os mesmos agentes infecciosos inflamando mucosas semelhantes — a mucosa endocervical na mulher e a mucosa uretral no homem. São causadas principalmente pela **Chlamydia trachomatis** (a mais comum) e pela **Neisseria gonorrhoeae** (gonococo), além de Trichomonas, Mycoplasma, entre outros.

Os fatores de risco incluem pacientes jovens, múltiplas parcerias sexuais, uso irregular de preservativo e histórico de ISTs. A maioria das infecções por clamídia e gonococo é **assintomática**. Quando sintomática, a cervicite apresenta **secreção vaginal mucopurulenta, disúria, dispareunia e colo uterino hiperemiado, friável** (que sangra facilmente ao toque).

A importância da cervicite vai além dela mesma: se a infecção ascende para o trato genital superior, estamos diante da **doença inflamatória pélvica** — e é exatamente o próximo tópico.

O diagnóstico é clínico, auxiliado por bacterioscopia (presença de **diplococos Gram-negativos** confirma gonococo) e, quando disponível, biologia molecular. O tratamento cobre os dois agentes simultaneamente: **ceftriaxona 500 mg IM, dose única** (para gonococo) + **azitromicina 500 mg, dois comprimidos VO, dose única** (para clamídia). O tratamento das parcerias sexuais é **obrigatório**.

Doença Inflamatória Pélvica (DIP)

A DIP é a **infecção/inflamação do trato genital superior feminino** por ascensão bacteriana a partir do trato genital inferior. É a evolução natural de uma cervicite não tratada: a infecção sobe e vai causando, progressivamente, **endometrite, salpingite, abscesso tubo-ovariano** e, nos casos mais graves, **peritonite**.

Os agentes são os mesmos da cervicite — clamídia e gonococo principalmente — e os fatores de risco se sobrepõem: comportamento sexual de risco, múltiplas

parcerias, uso irregular de preservativo, história prévia de ISTs, uso de DIU (risco baixo, porém existente) e presença de vaginose bacteriana.

O quadro clínico clássico é de **dor pélvica, dispareunia e febre**. Para fechar o diagnóstico, utilizamos critérios bem definidos:

Critérios maiores (as "três dores"): dor em baixo ventre ou à palpação ao toque bimanual; dor à palpação das regiões anexiais; e dor à mobilização do colo uterino. Essas três dores são o alicerce do diagnóstico clínico da DIP.

Critérios menores: febre (temperatura maior ou igual a 38,3 °C), secreção vaginal ou cervical alterada, massa pélvica, leucitose, aumento de PCR ou VHS, e comprovação laboratorial de infecção por clamídia ou gonococo.

Critérios elaborados: biópsia endometrial com achado de endometrite, imagem de abscesso tubo-ovariano ao ultrassom, ou evidências de DIP na videolaparoscopia. Esses são os critérios de certeza.

Para fechar o diagnóstico de DIP aguda: **três critérios maiores + pelo menos um critério menor, ou qualquer critério elaborado isoladamente**.

A classificação de gravidade segue os **estádios de Monif**:

Monif I — endometrite e salpingite sem peritonite, paciente com bom estado geral — tratamento **ambulatorial**.

Monif II — salpingite aguda com peritonite — tratamento **hospitalar**.

Monif III — salpingite com abscesso tubo-ovariano íntegro — tratamento **hospitalar** (inicialmente clínico, pode necessitar cirurgia).

Monif IV — abscesso tubo-ovariano roto — tratamento **cirúrgico** de emergência, com lavagem cavitária e antibioticoterapia hospitalar.

Tratamento ambulatorial (Monif I): ceftriaxona 500 mg IM dose única + doxiciclina 100 mg VO de 12/12h por 14 dias + metronidazol 500 mg VO de 12/12h por 14 dias.

A paciente deve ser reavaliada em **72 horas** — se não houver melhora clínica, deve ser internada.

Tratamento hospitalar: clindamicina 900 mg IV de 8/8h + gentamicina 240 mg IV uma vez ao dia, por 14 dias. Após melhora clínica e afebril por mais de 48 horas, pode-se transicionar para via oral e completar o esquema.

Mnemônico clássico para antibioticoterapia endovenosa em ginecologia: "Clinda e Genta, não inventa" — clindamicina + gentamicina é a combinação padrão para a maioria dos tratamentos hospitalares em ginecologia e obstetrícia.

Tratamento do parceiro: ceftriaxona 500 mg IM dose única + azitromicina 1 g VO dose única — esquema bem mais simples.

Ponto clássico de prova — DIP e DIU: se a paciente tem sinais de DIP no momento da consulta para inserção de DIU, **não se insere** — trata-se primeiro. Porém, se a paciente **já tem o DIU** e desenvolve DIP, **não é necessário retirar o DIU** de imediato, desde que se inicie o tratamento. A paciente é reavaliada em 72 horas e, só se não houver melhora clínica, retira-se o dispositivo.

Úlceras Genitais

Entramos agora no segundo grande bloco da aula. Para acertar qualquer questão de úlcera genital, grave o seguinte raciocínio de **três perguntas-chave**:

- 1. A úlcera é única ou múltipla?** Única: pode ser sífilis primária ou donovanose. Múltiplas: herpes genital, cancro mole ou linfogranuloma venéreo.
- 2. A úlcera é dolorosa ou indolor?** Dolorosa: herpes genital ou cancro mole. Indolor: sífilis primária, linfogranuloma venéreo ou donovanose.
- 3. Há linfadenopatia com fistulização?** Fistulização em orifício único: cancro mole. Fistulização em múltiplos orifícios ("bico de regador"): linfogranuloma venéreo. Sem fistulização: herpes genital, sífilis primária ou donovanose.

Respondendo a essas três perguntas, você identifica a etiologia com segurança. Vamos detalhar cada uma.

Herpes Genital

É a **úlceras genital mais comum no mundo**, causada pelo **Herpes Simplex Virus (HSV)**, tipos 1 e 2. O período de incubação varia de 2 a 26 dias. O quadro clássico inicia-se com **vesículas** (bolinhas com conteúdo líquido, citrino) extremamente dolorosas, que se rompem formando **úlceras rasas, de fundo limpo**. A dor é intensa. Na **primoinfecção**, a paciente pode apresentar **sintomas sistêmicos**: febre, mialgia, mal-estar e cefaleia, além de linfadenopatia inguinal dolorosa.

O diagnóstico é **eminentemente clínico**. Quando disponível, pode-se solicitar cultura de secreção, PCR da lesão ou sorologia. Uma decoreba clássica de prova: na citologia, podem ser encontradas as **células de Tzanck** — células gigantes multinucleadas.

Tratamento: primoinfecção — **aciclovir 400 mg VO de 8/8h por 7 a 10 dias**. Recorrência — aciclovir 400 mg VO de 8/8h por **5 dias**. Terapia supressiva (mais de 4 a 6 episódios por ano) — aciclovir 400 mg VO de **12/12h por 6 meses**.

Sífilis Primária (Cancro Duro)

Causada pelo **Treponema pallidum**, um espiroqueta que se manifesta cerca de **três semanas** após o contato sexual. A lesão clássica é uma **úlceras única, indolor, de bordos elevados e fundo limpo** — o **cancro duro**. Pode haver linfadenopatia inguinal, porém **indolor e sem fistulização**. Um detalhe importantíssimo: a lesão **desaparece espontaneamente em 3 a 4 semanas** sem deixar cicatriz, o que faz com que muitas pacientes nunca percebam a lesão, especialmente mulheres.

Diagnóstico laboratorial — testes treponêmicos vs. não treponêmicos:

Os **testes treponêmicos** (teste rápido, FTA-Abs, ELISA) positivam primeiro e **permanecem positivos para sempre**, independentemente do tratamento. Servem para **confirmação diagnóstica**.

Os **testes não treponêmicos** (VDRL, RPR) servem para **titulação e controle de tratamento**. Apresentam risco de **falso-positivo** em baixas titulações (1:1, 1:2), especialmente em pacientes com lúpus e algumas doenças hematológicas. Podem permanecer positivos em baixas titulações mesmo após tratamento adequado (cicatriz sorológica).

Dica fundamental: para confirmação diagnóstica em paciente não gestante, usa-se um teste treponêmico + um teste não treponêmico. Na **gestante**, um único teste positivo já é suficiente para iniciar o tratamento — não se pode perder tempo.

Tratamento:

Sífilis recente (primária, secundária e latente recente — menos de 1 ano) — **penicilina benzatina 2,4 milhões UI IM, dose única** (1,2 milhão em cada nádega).

Sífilis tardia (latente tardia, terciária ou duração indeterminada — mais de 1 ano) — **penicilina benzatina 2,4 milhões UI IM, uma vez por semana, por 3 semanas**.

Neurossífilis — penicilina cristalina endovenosa.

Cancro Mole (Cancróide)

Causado pela **Haemophilus ducreyi**, bactéria Gram-negativa, com período de incubação de 3 a 5 dias. O quadro clínico apresenta **úlceras múltiplas, dolorosas, de fundo sujo (purulento), com bordas irregulares**. Há **linfadenopatia inguinal dolorosa** que **fistuliza em orifício único** — esse é o ponto-chave de diferenciação com o linfogranuloma venéreo.

Na microscopia, pode-se observar o padrão clássico de **células em "cardume de peixe"** — mais uma decoreba importante.

Tratamento: azitromicina 1 g VO, dose única (primeira opção), ou ceftriaxona 250 mg IM dose única (segunda opção).

Comparação rápida herpes x cancro mole: ambos são múltiplos e dolorosos. Porém, o herpes tem **fundo limpo** e pode ser precedido por vesículas; o cancro mole tem **fundo sujo** e linfadenopatia que fistuliza.

Linfogranuloma Venéreo

Causado pela **Chlamydia trachomatis**, sorotipos **L1, L2 e L3**, com período de incubação de 4 a 30 dias. Apresenta três fases: na **fase primária**, surge uma úlcera genital **única e indolor** que desaparece espontaneamente — semelhante ao cancro duro da sífilis. Na **fase secundária**, a manifestação mais marcante é a **linfadenopatia inguinal dolorosa** com o clássico **sinal da fenda** (linfonodos acima e abaixo do ligamento inguinal formam um sulco), que **fistuliza em múltiplos orifícios, em "bico de regador"**. Na **fase terciária**, surgem sequelas como elefantíase genital, fístulas e estenoses.

Tratamento: doxiciclina 100 mg VO de 12/12h por 21 dias.

Donovanose

Causada pela **Klebsiella granulomatis**, com período de incubação extremamente variável (1 a 360 dias). O quadro clínico é de **úlceras múltiplas, indolores, com bordas hipertróficas, fundo granuloso e sangramento fácil**. Apesar do aspecto feio e destrutivo, a lesão **não dói**. Tem evolução **lenta, progressiva e crônica** (mais de 4 semanas). Um ponto-chave: **não há linfadenopatia**.

O diagnóstico exige **biópsia** da lesão quando há ulceração crônica (mais de 4 semanas), podendo-se evidenciar os **corpúsculos de Donovan** — inclusões intracitoplasmáticas que dão nome à doença.

Tratamento: azitromicina 1 g VO, uma vez por semana, por no mínimo 3 semanas ou até a cicatrização completa de todas as lesões.

Resumo - Úlceras genitais

Cancro mole: dolorosa, múltipla, linfadenopatia dolorosa com fístula em orifício único, fundo sujo. Tratamento: azitromicina 1 g dose única.

Herpes genital: dolorosa, múltipla, linfadenopatia sem fistulização, fundo limpo, pode ter vesículas prévias. Tratamento: aciclovir 400 mg 8/8h (7 dias na primoinfecção, 5 dias na recorrência).

Sífilis primária: indolor, única, linfadenopatia indolor sem fistulização, fundo limpo. Tratamento: penicilina benzatina 2,4 milhões UI dose única.

Linfogranuloma venéreo: indolor (úlceras), única, linfadenopatia dolorosa que fistuliza em múltiplos orifícios ("bico de regador"). Tratamento: doxiciclina 100 mg 12/12h por 21 dias.

Donovanose: indolor, múltipla, crônica, sem linfadenopatia, fundo granuloso. Tratamento: azitromicina 1 g semanal por mínimo 3 semanas.